

1. Introducción y relevancia clínica

El **desarrollo psicomotor (DSM)** representa la adquisición progresiva y ordenada de habilidades motoras, cognitivas, sociales y del lenguaje, que reflejan la **maduración del sistema nervioso central (SNC)**.

A diferencia del crecimiento físico —que se mide en peso, talla o perímetro cefálico—, el DSM evalúa la **evolución funcional del niño**, es decir, cómo va ganando autonomía, coordinación y capacidad de interacción con el entorno.

El **control del DSM** es un componente esencial del **Programa de Control del Niño Sano del MINSAL**, ya que permite detectar de forma temprana alteraciones del neurodesarrollo y aplicar intervenciones oportunas.

En el **EUNACOM**, este tema es muy frecuente, especialmente en preguntas sobre:

- Identificación de **hitos del desarrollo por edad**.
- Detección de **retrasos globales o específicos**.
- Aplicación de **tamizajes del desarrollo (EEDP, TEPSI)**.

Comprender la secuencia normal del desarrollo permite reconocer desviaciones precoces, diferenciar retrasos transitorios de patologías neurológicas y orientar adecuadamente a las familias.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Definición de desarrollo psicomotor

El DSM es el proceso de adquisición de habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas, sociales y afectivas que ocurren desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Depende de la **maduración cerebral**, la **estimulación ambiental** y la **integridad sensorial y motora** del niño.

2.2. Áreas del desarrollo psicomotor

El MINSAL y las escalas internacionales (Denver II, EEDP, TEPSI) dividen el DSM en **cuatro grandes áreas funcionales**:

1. **Área motora gruesa:** control postural, desplazamientos, equilibrio.
2. **Área motora fina-adaptativa:** coordinación ojo–mano, manipulación de objetos.
3. **Área lenguaje:** comprensión y expresión verbal.
4. **Área social-personal:** interacción, juego, autonomía e imitación.

Cada una se desarrolla en un orden secuencial, aunque puede haber **variaciones individuales leves** dentro de límites normales.

2.3. Principios del desarrollo psicomotor

1. **Cefalocaudal:** el control aparece desde la cabeza hacia los pies (primero sostiene la cabeza, luego se sienta y finalmente camina).
 2. **Proximodistal:** primero domina movimientos de los grandes segmentos corporales y luego los finos (brazos antes que dedos).
 3. **De lo general a lo específico:** movimientos globales → movimientos precisos.
 4. **Continuo y secuencial:** sigue un orden predecible, pero con ritmo individual.
-

2.4. Factores que influyen en el DSM

- **Biológicos:** genética, salud perinatal, nutrición, integridad sensorial.
 - **Psicosociales:** estimulación, vínculo afectivo, ambiente familiar.
 - **Culturales:** expectativas y prácticas de crianza.
 - **Patológicos:** enfermedades neurológicas, metabólicas, malformaciones o síndromes genéticos.
-

3. Clínica: hitos del desarrollo psicomotor por edad

Los hitos son las **conductas observables esperadas** a una determinada edad.

Su conocimiento permite evaluar el progreso normal del niño y detectar retrasos.

A continuación se presentan los principales hitos de cada área, según edad y guías MINSAL/OMS:

3.1. Recién nacido (0–1 mes)

- **Motor grueso:** movimientos reflejos (moro, prensión, búsqueda).
 - **Motor fino:** manos cerradas, prensión palmar refleja.
 - **Lenguaje:** llanto como principal forma de comunicación.
 - **Social:** fija brevemente la mirada al rostro humano.
-

3.2. 2 meses

- **Motor grueso:** sostiene parcialmente la cabeza.
- **Motor fino:** abre las manos espontáneamente.
- **Lenguaje:** vocaliza sonidos guturales (“arrullos”).
- **Social:** sonrisa social al estímulo humano.

Comentario EUNACOM:

La **sonrisa social a los 2 meses** es un hito clave y frecuentemente preguntado. Su ausencia puede indicar alteración visual o del vínculo.

3.3. 4 meses

- **Motor grueso:** sostiene la cabeza firmemente.
- **Motor fino:** sigue objetos con la mirada y los toma con ambas manos.
- **Lenguaje:** balbucea sonidos repetitivos.

- **Social:** responde a estímulos familiares (voz, rostro).
-

3.4. 6 meses

- **Motor grueso:** se sienta con apoyo, gira de supino a prono.
 - **Motor fino:** transfiere objetos de una mano a otra.
 - **Lenguaje:** emite sílabas (“ba”, “ma”).
 - **Social:** reconoce a sus cuidadores y muestra ansiedad ante extraños.
-

3.5. 9 meses

- **Motor grueso:** se sienta sin apoyo, gatea o se arrastra.
 - **Motor fino:** pinza inferior (pulgar y palma).
 - **Lenguaje:** balbucea repetitivamente (“mamama”, “papapa”).
 - **Social:** juega al “cu-cu” o “peek-a-boo”.
-

3.6. 12 meses (1 año)

- **Motor grueso:** se pone de pie y da pasos con apoyo.
- **Motor fino:** pinza superior (pulgar e índice).
- **Lenguaje:** dice “mamá”, “papá” con sentido.
- **Social:** imita gestos y saluda con la mano.

Comentario EUNACOM:

El uso de pinza superior y primeros pasos con apoyo al año son hitos claves; su ausencia requiere evaluación del desarrollo motor.

3.7. 18 meses

- **Motor grueso:** camina solo, sube escaleras con ayuda.
 - **Motor fino:** garabatea, construye torres de 2 cubos.
 - **Lenguaje:** dice 10–20 palabras, comprende órdenes simples.
 - **Social:** señala objetos, juega de forma paralela a otros niños.
-

3.8. 24 meses (2 años)

- **Motor grueso:** corre, pateo una pelota.
 - **Motor fino:** construye torres de 4–6 cubos, pasa páginas de un libro.
 - **Lenguaje:** frases de dos palabras, vocabulario de ~50 palabras.
 - **Social:** ayuda a vestirse, imita tareas domésticas.
-

3.9. 3 años

- **Motor grueso:** sube escaleras alternando pies, pedalea triciclo.
 - **Motor fino:** copia un círculo.
 - **Lenguaje:** frases de 3 palabras, comprende órdenes complejas.
 - **Social:** inicia juego cooperativo.
-

3.10. 4 años

- **Motor grueso:** salta en un pie, se mantiene en equilibrio.
- **Motor fino:** copia una cruz o cuadrado.
- **Lenguaje:** utiliza pronombres, narra experiencias simples.

- **Social:** juega con reglas sencillas, distingue género y edad.
-

3.11. 5 años

- **Motor grueso:** se viste solo, sube y baja escaleras sin ayuda.
 - **Motor fino:** dibuja figuras humanas con al menos 6 partes.
 - **Lenguaje:** habla con claridad, comprende conceptos espaciales.
 - **Social:** juega en grupo y sigue instrucciones colectivas.
-

3.12. 6 años y más

- **Motor grueso:** corre, salta, atrapa y lanza.
 - **Motor fino:** escribe su nombre, usa tijeras.
 - **Lenguaje:** estructura frases complejas, narra historias.
 - **Social:** juego cooperativo, inicio de integración escolar.
-

4. Exámenes complementarios y evaluación del desarrollo

El DSM se evalúa principalmente **por observación clínica y tamizaje estandarizado**, más que por exámenes de laboratorio.

4.1. Herramientas de tamizaje usadas en Chile

1. EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor):

- Aplica a niños de 0 a 24 meses.
- Evalúa 4 áreas: motor, coordinación, lenguaje y social.
- Clasifica como:

- **Normal:** 85–115%.
- **Riesgo:** 70–84%.
- **Retraso:** <70%.

2. TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor):

- Aplica a niños de 2 a 5 años.
- Evalúa: motricidad, coordinación y lenguaje.
- Resultado: normal, riesgo o retraso.

Comentario EUNACOM:

En EUNACOM suelen preguntar:

“¿Qué instrumento se utiliza en Chile para evaluar el desarrollo psicomotor en un niño de 18 meses?”

✓ Respuesta: **EEDP**.

“¿Y en un niño de 3 años?”

✓ Respuesta: **TEPSI**.

4.2. Criterios para derivación a especialista

- Pérdida de un hito previamente adquirido.
- Retraso de más de 2 meses respecto al promedio.
- Retraso en dos o más áreas del desarrollo.
- Sospecha de trastorno del espectro autista (TEA).
- Antecedente perinatal de riesgo neurológico.

5. Tratamiento y manejo

No existe “tratamiento” farmacológico del desarrollo, sino **intervención temprana multidisciplinaria** para potenciar las habilidades del niño.

1. **Estimulación temprana:** juegos, interacción, lectura, música.
 2. **Rehabilitación:** terapia física, ocupacional, fonoaudiología.
 3. **Control de factores de riesgo:** nutrición, salud visual y auditiva.
 4. **Educación a padres:** reforzar conductas positivas y vínculo afectivo.
 5. **Derivación oportuna:** a programas de estimulación MINSAL o servicios de rehabilitación comunitaria.
-

6. Complicaciones

- Retraso global del desarrollo.
 - Trastornos del lenguaje o del aprendizaje.
 - Trastorno del espectro autista.
 - Problemas conductuales y de integración social.
 - Déficit cognitivo y bajo rendimiento escolar.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El desarrollo sigue un patrón **céfalo-caudal y próximo-distal**.
2. **Sonrisa social (2 meses), pinza superior (1 año) y frases de 2 palabras (2 años)** son hitos clásicos en EUNACOM.
3. La **EEDP** se aplica hasta los 24 meses y la **TEPSI** desde los 2 hasta los 5 años.
4. La **pérdida de un hito** es más grave que el simple retraso.
5. La **estimulación temprana** es el pilar del tratamiento.

Errores comunes:

- Considerar patológico un leve retraso aislado.
 - Evaluar desarrollo solo por edad cronológica sin considerar edad corregida en prematuros.
 - No explorar las cuatro áreas del DSM.
 - No pesquisar alteraciones sensoriales (audición, visión).
 - No registrar los hitos en la cartilla del niño sano.
-

8. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **desarrollo psicomotor** refleja la maduración neurológica y la interacción con el entorno.
2. Se divide en **cuatro áreas**: motora gruesa, motora fina, lenguaje y social.
3. Los **hitos por edad** deben conocerse y registrarse en cada control.
4. Las herramientas chilenas oficiales son **EEDP (0–2 años)** y **TEPSI (2–5 años)**.
5. La **pérdida de habilidades adquiridas** es siempre signo de alarma.
6. En **EUNACOM**, las preguntas se centran en la edad de aparición de hitos clave y en los instrumentos de evaluación.